

GUÍA DE ESTUDIO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO

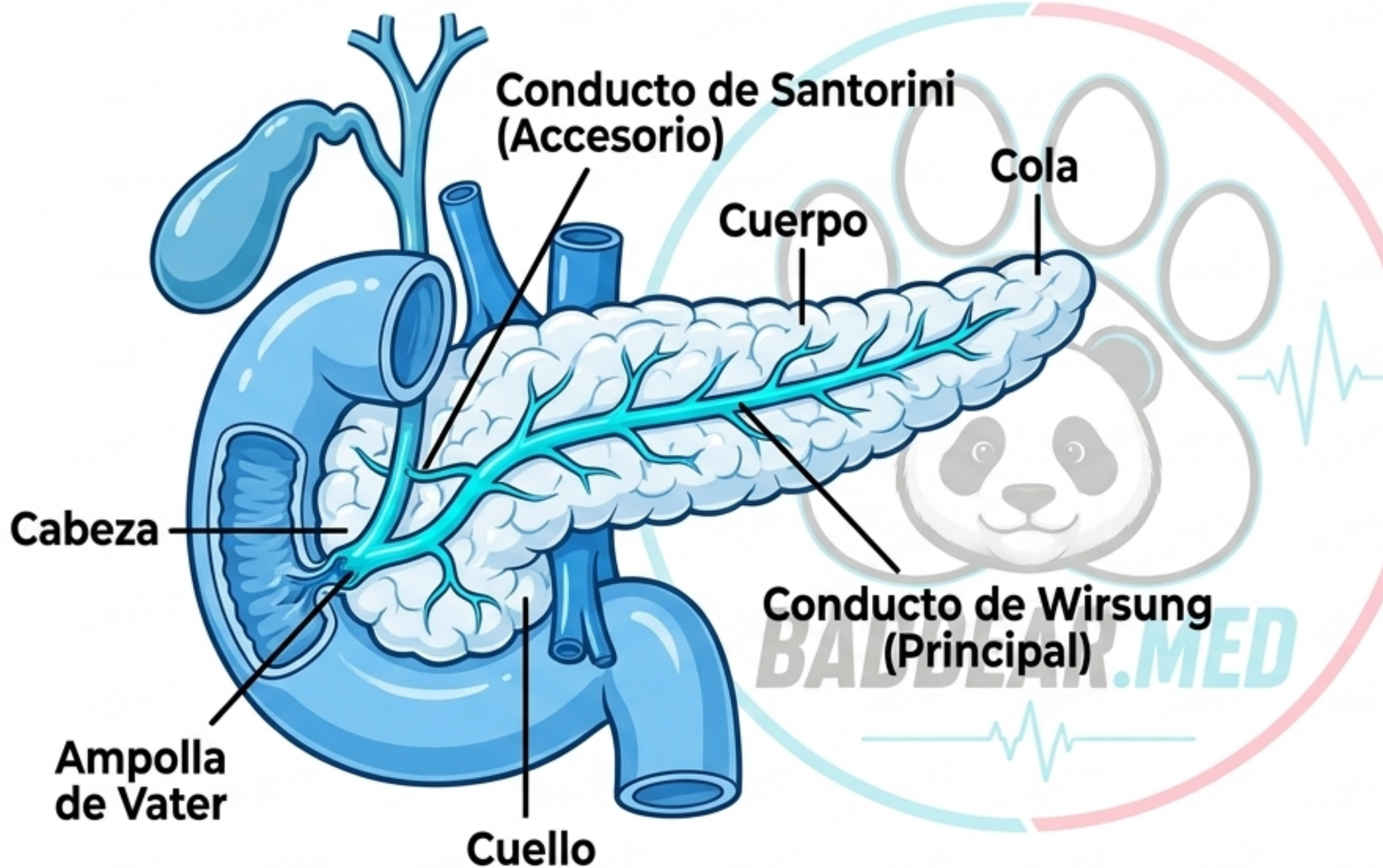
Patología Benigna y Maligna del Páncreas

Anatomía, Diagnóstico, y Resoluciones Quirúrgicas (Whipple)

BADBEAR.MED

BADBEAR.MED Exclusivo

Anatomía Quirúrgica del Páncreas



Dimensiones

Longitud: 15-20 cm

Ancho: 4-5 cm

Peso: 75-100 g

Ubicación

Órgano impar retroperitoneal.

Abrazado por el duodeno, íntima relación con arteria y vena mesentérica superior.

Fisiología Pancreática: Matriz Celular

Exocrino (95%): Producción de 500-800 ml/día de jugo pancreático.

Endocrino (5%)

Célula	Secreción	Función
Célula Beta (70%)	Insulina	Disminuye la glucemia.
Célula Alfa (20%)	Glucagón	Aumenta la glucemia.
Célula Delta (5%)	Somatostatina	Inhibición paracrina y reducción de contracciones del tubo digestivo (causa íleo).
Célula G (<1%)	Gastrina	Estimula ácido clorhídrico.
Célula PP (1%)	Polipéptido Pancreático	Inhibe secreción pancreática.

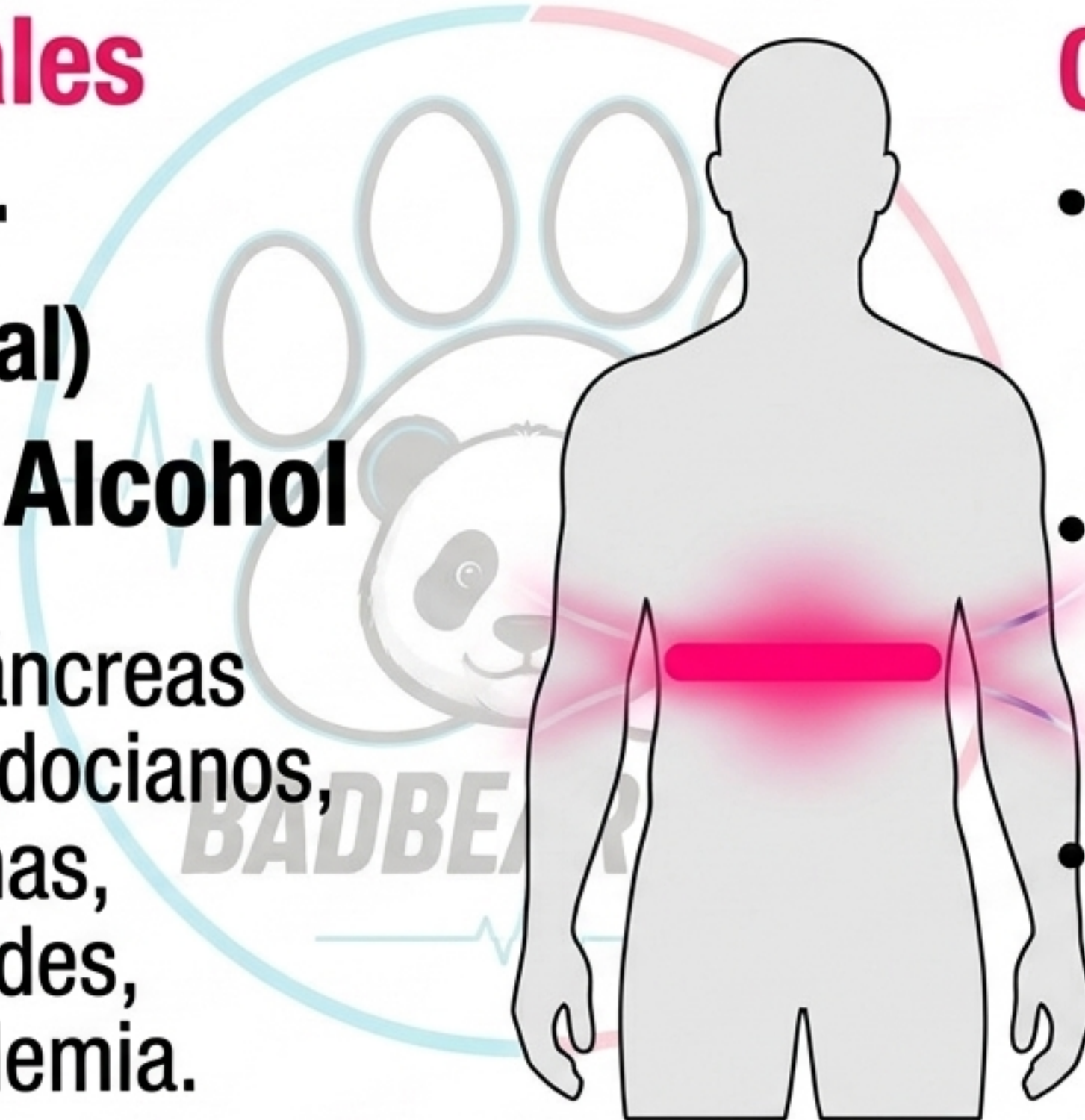
Pancreatitis Aguda: Etiología y Presentación Clínica

Causas Principales

#1 Litiasis Biliar
(Causa principal)

#2 Consumo de Alcohol

Otras: Parasitosis, Páncreas divisum, Quistes coledocianos, Fármacos (Tetraciclinas, Metronidazol, Esteroides, Diuréticos), Hiperlipidemia.

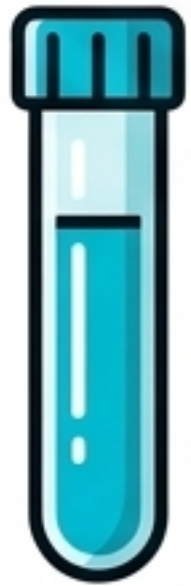


Cuadro Clínico

- **Dolor (90%):** Dolor abdominal de aparición brusca e intenso en epigastrio/mesogastrio.
- **Irradiación:** Clásico dolor “en barra” irradiado a la región dorso-lumbar (50% de los casos).
- **Signos Asociados:** Náuseas, vómitos, íleo paralítico, taquicardia.

Ruta Diagnóstica: Laboratorio e Imágenes

Enzimas Séricas



Amilasa: Elevada en 85% de casos. Poca especificidad (se eleva en 24h, puede normalizarse rápido).



Lipasa: Mayor utilidad clínica. Permanece elevada sangre por períodos más largos.

Imágenes



- **Tomografía Axial Computarizada (TAC) con Contraste:** Gold Standard. Método de mayor seguridad. Detecta aumento de tamaño, contornos irregulares, necrosis y pseudoquistes.
- **Ecografía:** Útil inicialmente para detectar la causa biliar (piedras).

Criterios de Severidad y Mortalidad (Ranson)

Parámetros Clave a 48h

Edad: >55 (Biliar >79)

Leucocitos: >16,000 (Biliar >18,000)

Glucosa: >200 mg/dL

LDH: >350 UI/L (Biliar >400)

Staircase of Mortality

0-2 Criterios = 1%
Mortalidad (Leve)

3-4 Criterios =
16% Mortalidad
(Grave)

5-6 Criterios =
40% Mortalidad

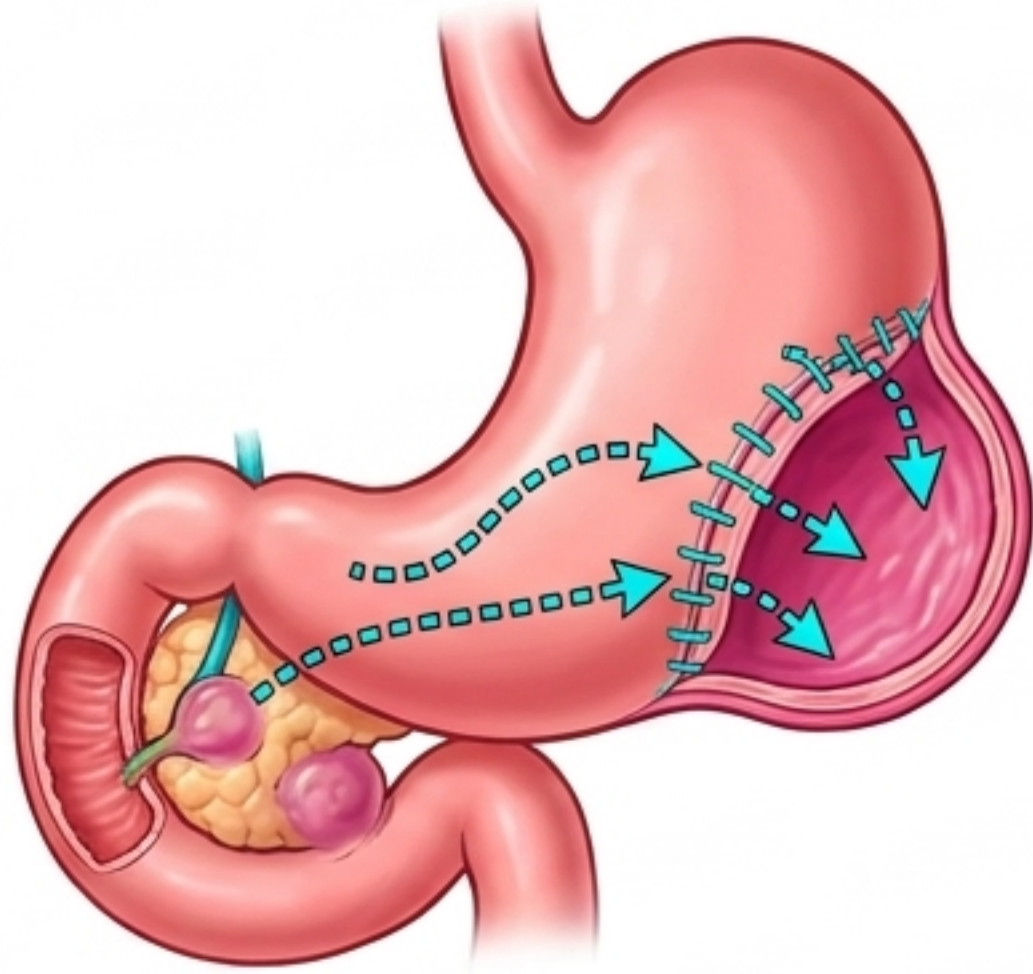
7-8+ Criterios =
100% Mortalidad

Evolución y Complicaciones Locales: Pseudoquiste Pancreático



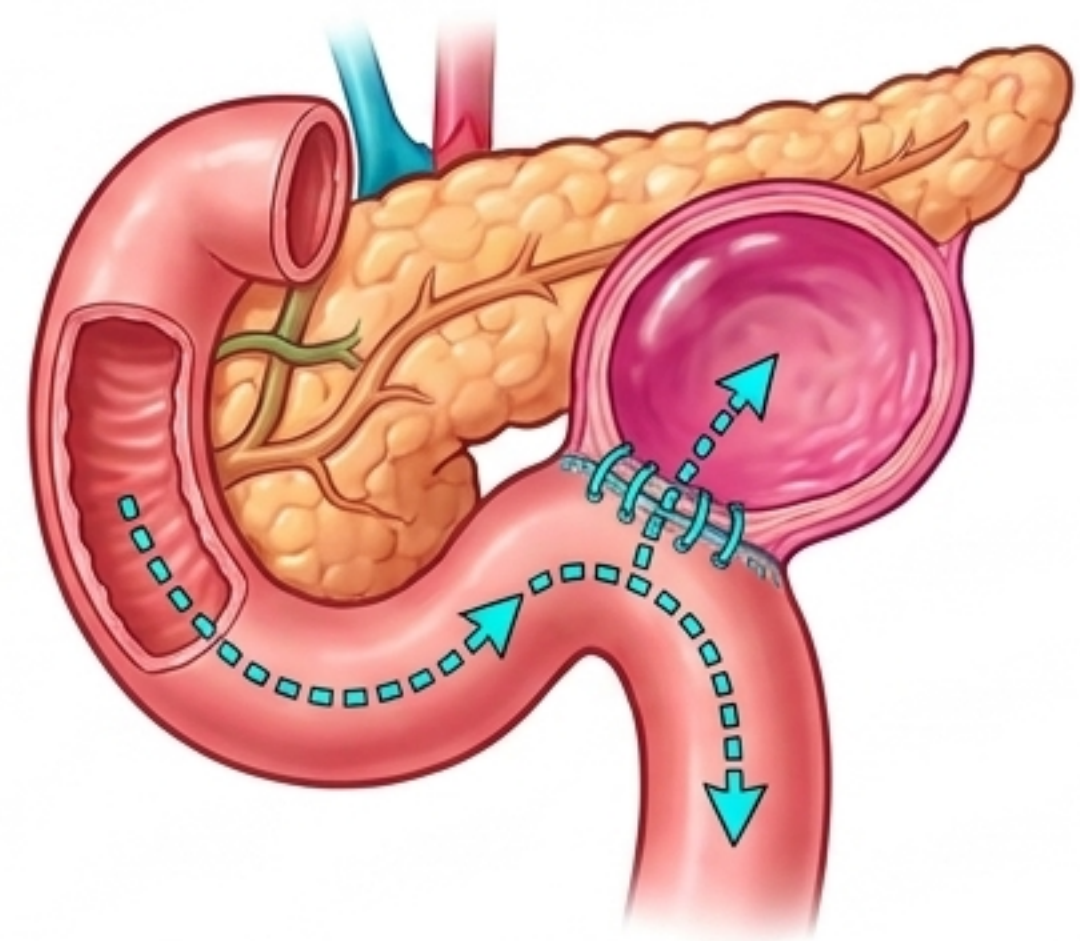
Resolución Quirúrgica de Pseudoquistes (Necrosectomía)

Contexto: Se opera a partir de la 4ta-6ta semana cuando la pared del pseudoquiste está engrosada y madura.



Cistogastrostomía

- **Ubicación:** Pseudoquistes en la Cabeza del páncreas.
- **Técnica:** Unión de la pared anterior del pseudoquiste con la cara posterior del estómago. El contenido drena al tracto digestivo.

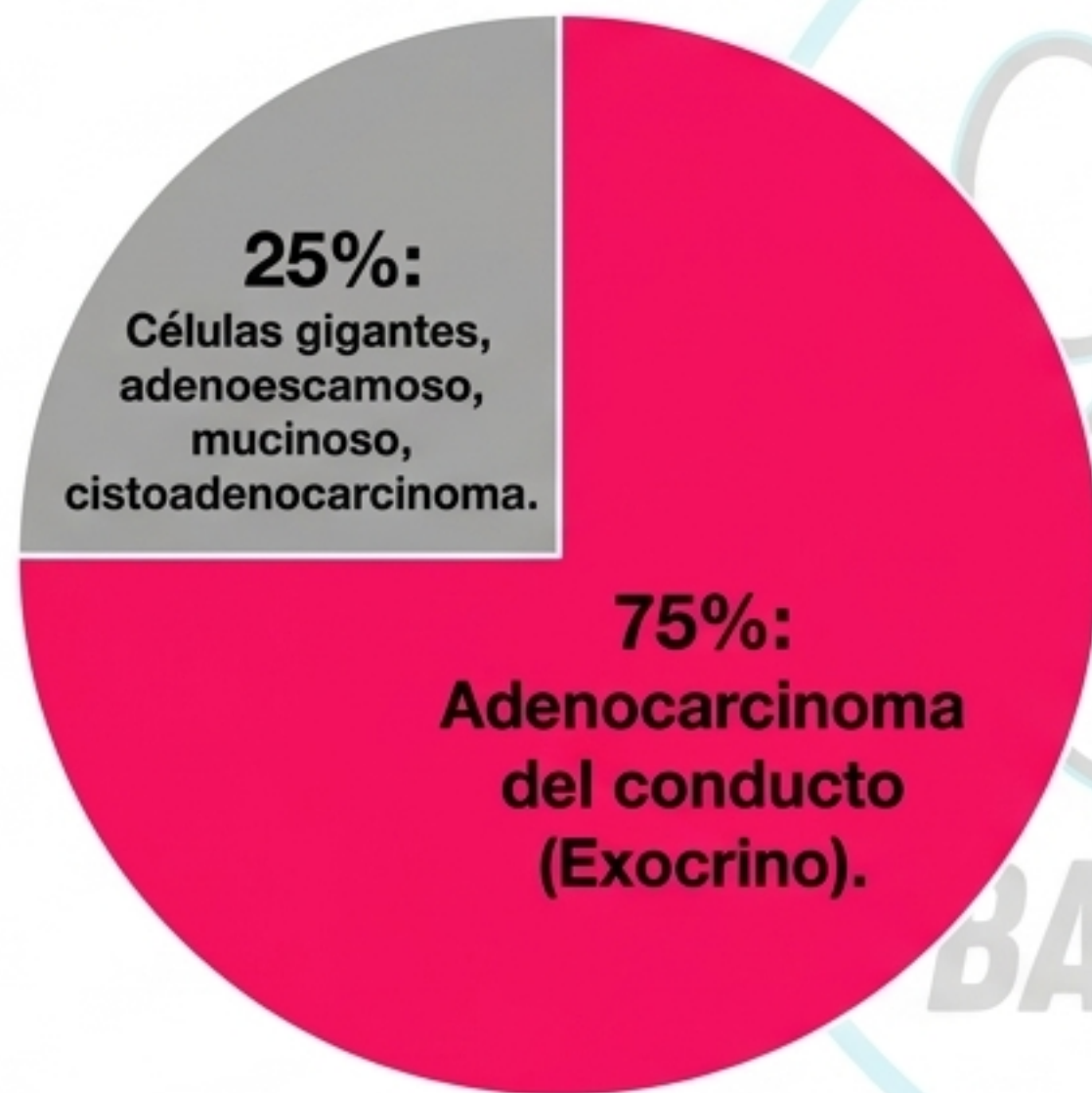


Cistoyeyunostomía

- **Ubicación:** Pseudoquistes en Cuerpo o Cola.
- **Técnica:** Unión del pseudoquiste con el intestino delgado (yeyuno) mediante sutura mecánica/automática.

Neoplasias Pancreáticas: Epidemiología y Mortalidad

Clasificación Maligna - 98% del total



Excepción (Sobrevida del 20% a 5 años):
Solo si el tumor es < 2 cm, localizado en la cabeza, sin metástasis ni invasión a órganos vecinos.

Presentación Clínica: La Tríada Clásica

1. Pérdida de Peso
(70% bajan 10-15 kg
en un mes)

2. Dolor abdominal sordo
(irradiado a dorso)

**Tumor en
Cabeza de
Páncreas**

3. Ictericia y Prurito
(por obstrucción
del colédoco)

Signo de Courvoisier-Terrier:
Vesícula biliar palpable, distendida y
NO dolorosa en un paciente icterico.
Altamente sugestivo de neoplasia
periampular o de cabeza de
páncreas.

Biología Tumoral y Marcadores Diagnósticos

K-ras (Mutación del codón 12)	Prevalencia: 70% (Vivid Magenta for 70%) Muestra: Sangre, heces, jugo pancreático. Gran estimulador de proliferación celular.
CA 19-9	Utilidad Clínica: Específico para diagnóstico junto con CEA. Vital para medir recurrencia post-operatoria (Vivid Magenta for recurrencia post-operatoria).
CEA (Antígeno Carcinoembrionario)	Utilidad Clínica: Orientación diagnóstica (ayuda a diferenciar de cáncer de colon).
Alteración P53	Prevalencia: 50% (Vivid Magenta for 50%) Mecanismo: Alteración del gen supresor.

Neoplasias Endocrinas Funcionales (Islotes de Langerhans)

Síndrome/Tumor	Secreción	Malignidad	Ubicación
Síndrome de Zollinger-Ellison	Gastrina	60-90%	Duodeno (70%), Páncreas (25%)
Insulinoma	Insulina	Baja (<10%)	Páncreas (>99%)
Glucagonoma	Glucagón	50-80%	Páncreas (50%)
Somatostatinoma	Somatostatina	Alta	Páncreas (5%), Duodeno/Yeyuno (44%)

Criterios de Irresecabilidad Quirúrgica

Contexto: Si el tumor presenta alguna de estas características, la cirugía radical (Whipple) está contraindicada. Solo procede tratamiento paliativo (Bypass / Stent).

1. Presencia de **Ascitis**:

Indica diseminación peritoneal de células cancerígenas.

2. **Metástasis** a Distancia:

Compromiso evidente en Hígado o Pulmones.

3. **Invasión Vascular**:

Compromiso infiltrativo de la Vena Porta o los Vasos Mesentéricos Superiores.

4. **Infiltración Retroperitoneal**:

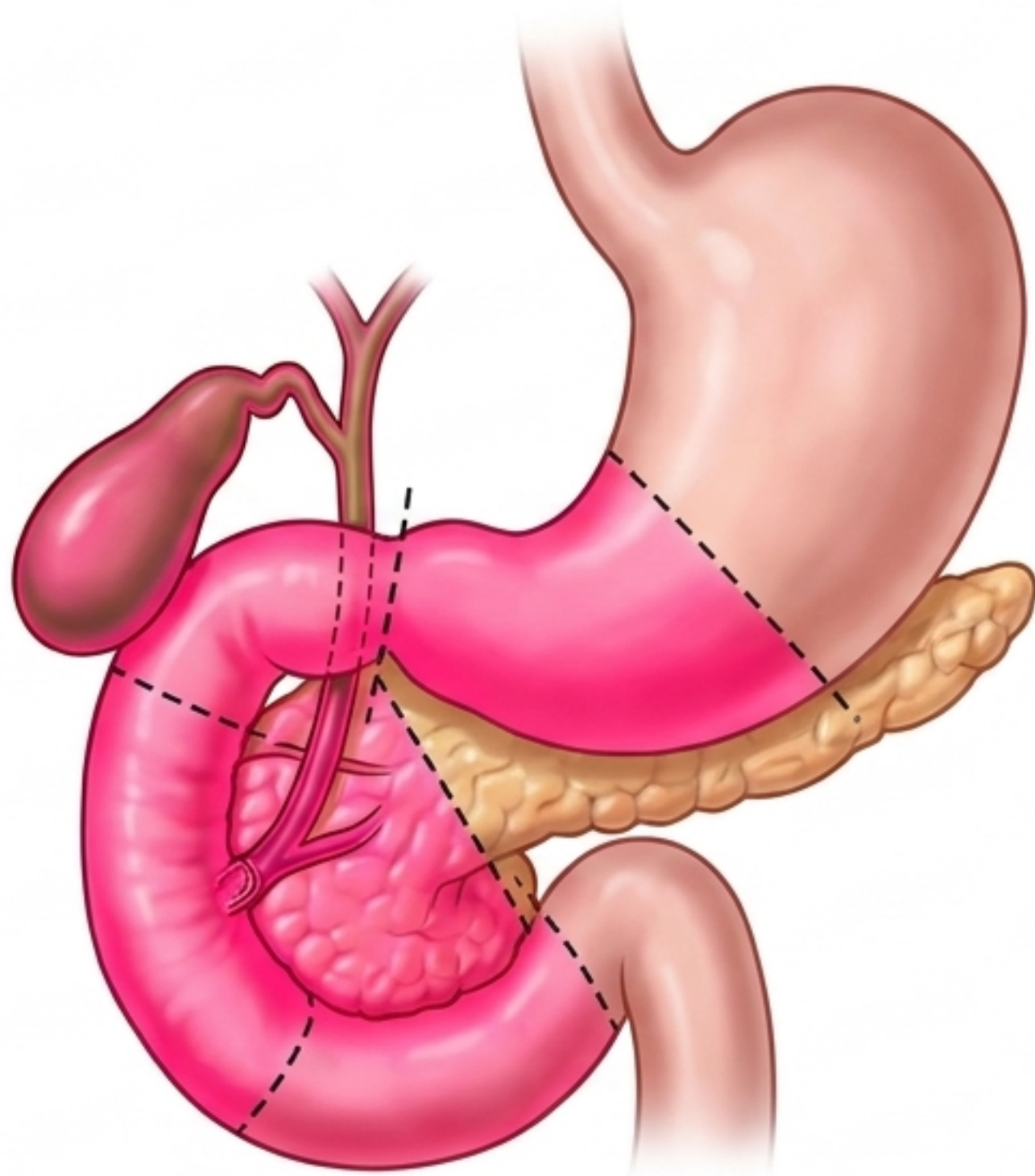
Compromiso de los planos retroperitoneales profundos.

STOP



Operación de Whipple (Resección)

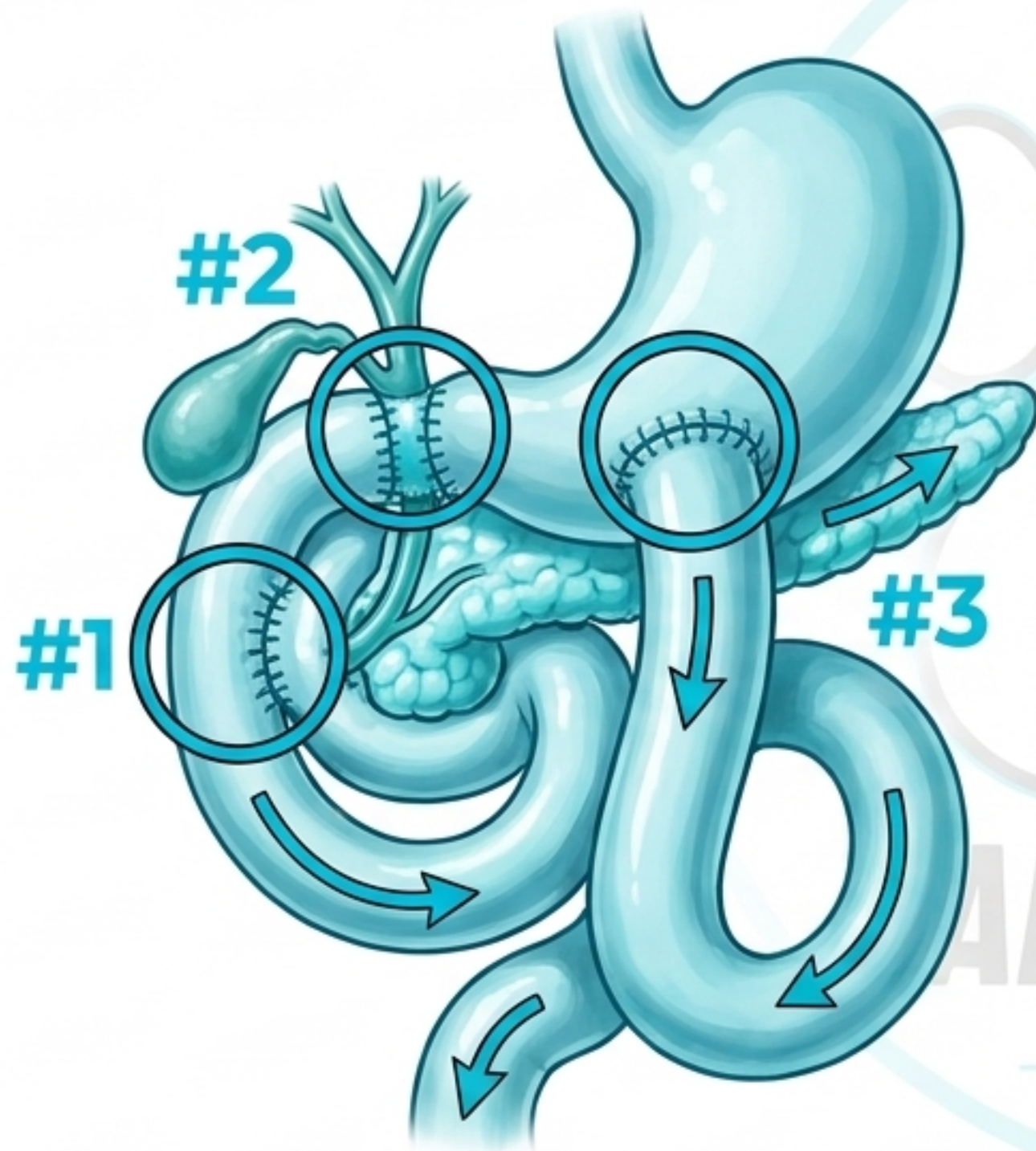
Duodenopancreatectomía Cefálica - ¿Qué se extirpa?



- **1. Cabeza del Páncreas** (hasta el cuello/transición).
- **2. Duodeno completo** (hasta la cuarta porción).
- **3. Colédoco distal y Vesícula Biliar** (Colecistectomía).
- **4. Antro Gástrico (50% del estómago)** — **Nota:** Existe variante con preservación del píloro para evitar el síndrome de Dumping.
- **5. Ganglios linfáticos regionales.**

Operación de Whipple (Reconstrucción)

Las 3 Anastomosis Vitales (En orden quirúrgico)



#1: Pancreatoyeyunostomía: Unión del muñón del páncreas al yeyuno (Término-lateral). **Alerta:** La falla de esta sutura causa Fístula Pancreática, la complicación post-operatoria más temida.

#2: Hepaticoyeyunostomía: Unión de la vía biliar remanente al yeyuno.

#3: Gastroyeyunostomía: Unión del estómago al yeyuno para restaurar el tránsito alimenticio.

Nota: Cirugía oncológica magna; tiempo quirúrgico reducido de 8-12 hrs a 4.5 hrs gracias a suturas automáticas.